

LA PROTECTION SOCIALE AU SÉNÉGAL : ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE, MUTATIONS POLITIQUES ET ENJEUX D'INCLUSION ÉCONOMIQUE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La problématique de la protection sociale s'inscrit au cœur des stratégies de développement économique, de réduction de la pauvreté et de consolidation de la paix civile dans les États en mutation rapide du Sud global. Analyser la **protection sociale au Sénégal**, c'est étudier l'ensemble des mécanismes juridiques, financiers, institutionnels et socio-éducatifs que l'État et ses partenaires déploient pour prémunir les populations contre les risques sociaux tout au long de leur existence. Ces risques incluent la maladie, l'invalidité, la vieillesse, le chômage, la maternité, la charge de famille ou la précarité extrême. La protection sociale ne saurait être réduite à une simple politique d'assistance passive ou à de la charité publique. Elle constitue un droit constitutionnel fondamental, un investissement socialement productif et un levier d'**ingénierie publique** majeur, indispensable pour transformer le dividende démographique en moteur de croissance durable. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

L'origine historique du concept de protection sociale au Sénégal témoigne de la rencontre et du choc entre des logiques de solidarité endogènes et des systèmes formels importés. Dans la société sénégalaise précoloniale, la gestion des risques reposait sur les structures de la famille élargie, du lignage, de la communauté villageoise et des corporations de métiers. Des institutions anthropologiques comme le *santé* (l'entraide), le *mboolo* (le regroupement) ou le *dimbali* (le soutien mutuel) garantissaient un filet de sécurité informel mais contraignant à chaque membre du groupe face aux chocs (maladie, mauvaises récoltes, vieillesse). La colonisation française a introduit les premiers mécanismes formels de sécurité sociale, calqués sur le modèle bismarckien et réservés exclusivement aux fonctionnaires métropolitains et aux salariés des grands comptoirs coloniaux. Après l'indépendance en 1960, le Sénégal a hérité de ce système dual, caractérisé par un secteur formel ultra-minoritaire et une économie informelle et rurale largement dépendante des solidarités traditionnelles. [\[1\]](#)

L'évolution du concept dans le temps est jalonnée de réformes structurelles profondes, passant d'une logique d'assurance professionnelle d'élite à une ambition d'**universalisme d'inclusion**. Les décennies 1980 et 1990, marquées par la crise de la dette et la mise en œuvre rigoureuse des Programmes d'Ajustement Structurel (PAS) imposés par les institutions de Bretton Woods, ont provoqué un désengagement forcé de l'État des secteurs sociaux (santé, éducation, prévoyance). Cette dynamique a entraîné une explosion de la précarité et une fragilisation des solidarités traditionnelles sous le coup de l'exode rural. Face à cet échec, le début du vingt-et-unième siècle a vu naître le paradigme des **filets de sécurité sociale** (*social safety nets*), conceptualisé par la Banque mondiale, évoluant par la suite vers l'élaboration d'une politique nationale intégrée et transversale de protection sociale, adossée à la vision d'un développement inclusif. [\[1\]](#)

L'importance contemporaine de cette thématique est capitale pour la performance publique et la stabilité de l'État. Dans un contexte caractérisé par l'extrême jeunesse de la population, la prépondérance de l'économie informelle (qui occupe plus de 90 % de la population active) et la récurrence des chocs macroéconomiques et climatiques, la refonte du système de protection sociale est une urgence absolue. Pour les candidats aux grands concours administratifs sénégalais (CFJ, ENA,

Douanes, Impôts et Domaines, Trésor, Travail, Administration générale), la maîtrise de cette matière est un prérequis incontournable. Les épreuves écrites et orales évaluent l'aptitude des candidats à analyser la viabilité financière de ces dispositifs, à décoder l'articulation entre politiques sectorielles et budgétaires, et à proposer des réformes managériales innovantes conformes aux critères de la gouvernance moderne.

La problématique générale qui structure ce cours universitaire peut s'énoncer de la manière suivante : Comment l'État du Sénégal parvient-il à bâtir un système de protection sociale universel, pérenne et financièrement viable, capable de couvrir l'immense majorité des travailleurs de l'économie informelle et du monde rural, tout en surmontant le cloisonnement bureaucratique et la rareté des ressources budgétaires ? [\[1\]](#)

Pour élucider cette problématique, ce développement universitaire s'articulera autour de quatre axes fondamentaux. La première partie examinera les fondements théoriques et conceptuels de la protection sociale au Sénégal. La deuxième partie proposera une analyse approfondie des mécanismes opérationnels, ainsi que des dimensions politiques, juridiques, économiques et administratives du système. La troisième partie mettra en relief les enjeux nationaux, continentaux et internationaux contemporains. Enfin, la quatrième partie déploiera une analyse critique des forces, des limites et des perspectives d'avenir de cette ingénierie sociale.

PREMIÈRE PARTIE : FONDEMENTS THÉORIQUES ET CONCEPTUELS

Définitions fondamentales

La définition doctrinale de la protection sociale la caractérise comme l'ensemble des interventions d'institutions publiques ou privées destinées à alléger la charge que représente pour les ménages ou les individus la survenue d'un certain nombre de risques ou de besoins sociaux. La doctrine contemporaine distingue trois logiques d'action : la logique d'**assurance sociale**, inspirée du modèle bismarckien, qui vise à prémunir les travailleurs contre la perte de revenus liée aux risques professionnels et dont le financement repose sur des cotisations sociales ; la logique d'**assistance sociale**, inspirée du modèle beveridgien, qui cherche à garantir un revenu minimum et un accès aux services de base pour tous les citoyens en situation d'indigence, sans contrepartie de cotisation, financée par l'impôt ; et la logique de l'**émergence par l'autonomisation**, qui vise le développement des capacités des bénéficiaires pour les sortir durablement de la dépendance. [\[1, 2\]](#)

Sur le plan juridique, la protection sociale au Sénégal relève du bloc de constitutionnalité et du droit international positif. La Constitution sénégalaise consacre le droit à la santé, à l'éducation et à la protection contre l'exclusion. Le système juridique distingue le régime légal obligatoire de sécurité sociale, géré par des institutions parétatiques ou publiques (Caisse de Sécurité Sociale, Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, Fonds National de Retraite), et les régimes d'assistance ou d'assurance volontaire (mutuelles de santé), encadrés par des textes réglementaires spécifiques qui fixent les droits et obligations des cotisants et des bénéficiaires. [\[1, 2\]](#)

Au niveau institutionnel, le système sénégalais est structuré par une dualité organisationnelle marquée. D'un côté, la protection sociale contributive (la sécurité sociale formelle) s'adresse aux fonctionnaires de l'État et aux salariés du secteur privé moderne régis par le Code du travail. De l'autre côté, la protection sociale non contributive et communautaire cible les populations pauvres, le monde rural et les acteurs de l'informel à travers des programmes de transferts monétaires, des gratuités de soins et un réseau de mutuelles de santé de proximité. Cette segmentation institutionnelle conditionne l'efficacité globale du système et l'allocation des budgets de l'action publique. [\[1, 2, 3\]](#)

Origines historiques

L'analyse de la période précoloniale révèle une absence de structures étatiques formalisées de protection sociale, la sécurité individuelle étant intrinsèquement liée à la cohésion du groupe. Le modèle anthropologique sénégalais traditionnel reposait sur la centralité de la terre et de la famille élargie comme amortisseurs universels des risques. Les systèmes de parenté, d'alliances matrimoniales, de classes d'âge (*compé*) et de caisses communautaires villageoises constituaient un réseau dense de solidarités réciproques. L'introduction de l'Islam a consolidé ces dynamiques à travers l'institutionnalisation de la **Zakat** (l'aumône légale) et de la solidarité confrérique, qui ont fonctionné comme les premiers filets de sécurité sociale formalisés par des principes éthiques et spirituels.

La colonisation française opère un tournant majeur en introduisant une rupture administrative fondamentale. En application du Code du travail des territoires d'outre-mer de 1952, l'administration coloniale met en place les premières prestations familiales et la couverture des accidents du travail au profit exclusif des salariés de la fonction publique et du commerce colonial des « Quatre Communes » (Dakar, Gorée, Rufisque, Saint-Louis). Ce système laissait de côté plus de 95 % de la population indigène, considérée comme hors du salariat formel, créant ainsi les bases du dualisme structurel qui caractérise encore aujourd'hui la protection sociale africaine.

L'époque post-indépendance (les décennies 1960 et 1970) a vu le jeune État sénégalais consolider et nationaliser cet héritage colonial. L'année 1973 est marquée par la création de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) pour la gestion des prestations familiales et des accidents du travail des salariés, et de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) pour les pensions du secteur privé. Le Fonds National de Retraite (FNR) gère quant à lui les pensions des agents de la fonction publique. Cette période de croissance modérée permettait d'envisager une extension progressive du salariat formel, un espoir brisé par les crises économiques successives. [\[1\]](#)

Les évolutions récentes, consécutives à la crise des années 1980 et à la dévaluation du franc CFA en 1994, ont obligé le Sénégal à réinventer son ingénierie sociale. Face à l'incapacité des systèmes formels à couvrir la majorité de la population et face à l'effritement des solidarités familiales urbaines, l'État a adopté en 2005 sa première Stratégie Nationale de Protection Sociale. Celle-ci a été profondément restructurée sous le régime du Président Macky Sall avec le lancement en 2014 de la Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS) intégrée au Plan Sénégal Émergent, puis réaffirmée par les nouvelles orientations de souveraineté économique et de justice sociale du Plan « Sénégal 2050 ». [\[1\]](#)

Théories et courants de pensée

La théorisation des modèles de protection sociale s'appuie sur des auteurs majeurs des sciences économiques et de la sociologie politique. Otto von Bismarck, chancelier de l'Empire allemand au dix-neuvième siècle, est le père du modèle de l'**assurance sociale**. Fondé sur le travail, ce modèle postule que la protection sociale est un droit professionnel financé par des cotisations patronales et salariales assises sur le salaire, géré par les partenaires sociaux et destiné à maintenir le revenu du travailleur en cas de réalisation du risque. C'est ce logiciel théorique qui gouverne le fonctionnement actuel de l'IPRES et de la Caisse de Sécurité Sociale au Sénégal. [\[1\]](#)

William Beveridge, économiste britannique auteur du rapport fondateur de 1942, théorise le modèle de l'**assistance sociale et de l'universalisme**. Beveridge prône la création d'un système unique, universel et uniforme, couvrant l'ensemble de la population contre les « cinq grands maux » (la maladie, l'ignorance, l'indigence, la saleté et l'oisiveté). Financé par l'impôt et géré par l'État, ce

modèle repose sur le principe de la citoyenneté et non plus du travail, une approche théorique qui inspire les programmes contemporains de gratuité des soins et de transferts monétaires universels portés par les administrations publiques.

Dans le champ de la sociologie de l'État providence, l'économiste danois Gøsta Esping-Andersen introduit le concept majeur de la **démarchandisation**. Esping-Andersen classe les États providences en fonction du degré auquel un citoyen peut librement se retirer du marché du travail sans perdre ses revenus essentiels ni compromettre sa survie sociale. Il distingue le modèle libéral (faible démarchandisation, ciblage des plus pauvres), le modèle corporatiste-conservateur (démarchandisation liée au statut professionnel) et le modèle social-démocrate (haute démarchandisation universelle), mettant en évidence les difficultés des pays en développement, caractérisés par une « marchandisation sauvage » due à l'absence de filets de sécurité formels pour la majorité informelle. [1]

La théorie des **capabilités** d'Amartya Sen fournit le socle conceptuel des politiques modernes d'assistance active au Sénégal. Sen démontre que la protection sociale ne doit pas se limiter à un traitement palliatif de la pauvreté par la distribution de secours monétaires passifs, ce qui risquerait de créer une culture de la dépendance. Elle doit viser la transformation des opportunités réelles des individus en libertés d'action concrètes. L'octroi d'une bourse familiale ou la gratuité des soins pour un enfant sont théorisés comme des tuteurs de capacité qui préservent le capital humain, stimulent l'éducation et permettent à l'individu de s'insérer activement dans le tissu productif national. [1, 2]

DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE APPROFONDIE DU THÈME

Les mécanismes de fonctionnement

Le système de protection sociale au Sénégal fonctionne selon deux architectures parallèles et asymétriques. Le premier mécanisme est le **régime contributif formel**. Il s'adresse aux travailleurs du secteur public (fonctionnaires civils et militaires) et aux salariés du secteur privé moderne déclarés. Les cotisations sont collectées à la source par l'employeur et reversées à la Caisse de Sécurité Sociale pour la couverture des accidents du travail et des prestations familiales, et à l'IPRES pour la retraite par répartition. Les fonctionnaires bénéficient de la part de l'État d'un régime de pension direct géré par le Fonds National de Retraite et d'une couverture médicale via les Institutions de Prévoyance Maladie (IPM). [1]

Le second mécanisme est le **régime non contributif et solidaire**. Déployé à grande échelle au cours des dernières décennies, il cible l'immense majorité des Sénégalais exclus du salariat. Le pivot de ce mécanisme est le **Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF)**, qui alloue un transfert monétaire trimestriel direct aux ménages répertoriés en situation d'extrême pauvreté. Ce mécanisme est complété par des politiques de gratuité des soins (le plan Sésame pour les personnes âgées, la gratuité de la césarienne, la gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans) et par le réseau des Mutuelles de Santé Communautaires, subventionnées à hauteur de 50 % par l'État pour permettre aux populations du secteur informel et rural de bénéficier d'une couverture maladie de proximité. [1, 2, 3, 4, 5]

Les principes fondamentaux

L'ingénierie de la protection sociale sénégalaise repose sur des principes directeurs cardinaux issus de sa charte stratégique. Le premier est le principe de **l'équité et de l'inclusion sociale**. Il exige que l'action publique corrige de manière délibérée les disparités géographiques et socio-économiques entre le milieu urbain favorisé et les zones rurales ou périphériques sinistrées, en orientant

prioritairement les ressources de la solidarité nationale vers les groupes les plus vulnérables (personnes en situation de handicap, femmes chefs de ménage, enfants talibés). [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Le deuxième principe est la **transversalité et la coordination interinstitutionnelle**. La protection sociale étant par nature multidimensionnelle, son efficacité dépend de la capacité de l'administration à briser le cloisonnement ministériel pour faire converger les volets sanitaires, éducatifs, financiers et d'insertion professionnelle autour de la famille bénéficiaire. S'y ajoute le principe de la participation communautaire, indispensable pour garantir la transparence, l'appropriation locale et la légitimité des mécanismes de ciblage des bénéficiaires sur le terrain. [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Les dimensions politiques et juridiques

Sur le plan politique, le choix du modèle de protection sociale est un indicateur de la philosophie républicaine de l'État. Au Sénégal, l'institutionnalisation des bourses familiales et de la couverture maladie universelle traduit la volonté d'édifier un modèle de croissance inclusive, où la solidarité nationale fonctionne comme un mécanisme de redistribution des fruits de l'émergence économique. C'est un vecteur de cohésion sociale et de légitimité politique majeur, car la réduction de la pauvreté extrême atténue le sentiment d'injustice sociale et stabilise les zones urbaines et rurales sujettes aux tensions.

Sur le plan juridique, la protection sociale s'inscrit dans un cadre légal et réglementaire dense mais morcelé. L'ordonnancement juridique est structuré par le Code du travail, le Code de la sécurité sociale de 1973, la Loi d'orientation sociale de 2010 pour les personnes en situation de handicap, et les décrets portant création de la Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSSN) et de l'Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle (SEN-CMU). Le droit sénégalais intègre également le Code de la Prévoyance Sociale de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), une institution régionale chargée d'harmoniser et de contrôler les caisses de sécurité sociale d'Afrique de l'Ouest et Centrale, garantissant le respect des droits des assurés sociaux et la régularité de la gestion financière.

Les dimensions économiques, sociales et administratives

La dimension économique de la protection sociale met en exergue l'arbitrage crucial entre la soutenabilité budgétaire à court terme et le rendement de l'investissement social à long terme. Le financement des bourses familiales et des gratuités médicales pèse sur le budget général de l'État, ce qui soulève régulièrement des débats sur l'étroitesse de l'assiette fiscale du pays et la nécessité de mobiliser des mécanismes de **financement innovants** (taxes douanières affectées, contributions sur le secteur des télécommunications ou des industries extractives). Pourtant, les analyses macroéconomiques démontrent que la protection sociale stimule la consommation locale des ménages pauvres, protège les actifs productifs contre les chocs de santé et favorise la scolarisation des enfants, renforçant ainsi la productivité globale de l'économie sénégalaise.

Au niveau social, la protection sociale est un puissant outil de déconstruction des processus d'exclusion et de paupérisation. Elle permet de substituer une solidarité nationale formelle, égalitaire et citoyenne à une dépendance clientéliste ou à une précarité relationnelle destructrice pour la dignité humaine. Administrativement, le système sénégalais fait face au défi majeur de l'unification de son système d'information. La gouvernance du secteur requiert une interopérabilité des fichiers administratifs pour optimiser le fonctionnement du **Registre National Unique (RNU)**, éliminer les fraudes, réduire les coûts de gestion bureaucratique et garantir une transparence totale dans l'attribution des prestations.

TROISIÈME PARTIE : ENJEUX CONTEMPORAINS

Enjeux nationaux : Le cas du Sénégal

Le Sénégal affronte aujourd'hui le défi de la modernisation et de la pérennisation de son architecture de protection sociale dans un contexte macroéconomique marqué par des impératifs de souveraineté et d'équité territoriale. Le pays fait face à l'urgence de couvrir l'immense réservoir de main-d'œuvre constitué par l'économie informelle (artisans, commerçants ambulants, conducteurs de motos-taxis, mareyeurs) et le monde rural (agriculteurs, éleveurs), qui subissent de plein fouet les fluctuations des cours des matières premières et les aléas climatiques (sécheresses, inondations).

Pour répondre à ces enjeux, les politiques publiques ont initié le processus d'unification et de digitalisation du **Registre National Unique (RNU)**, qui a été étendu pour répertorier des millions d'individus vulnérables. Le RNU constitue désormais la plateforme technologique universelle sur laquelle s'appuient l'ensemble des interventions d'urgence de l'État, des ONG et des partenaires au développement, garantissant un ciblage scientifique basé sur la méthode du test des besoins (*Proxy Means Testing*). [\[1\]](#)

Cependant, des failles opérationnelles importantes subsistent. Le financement de la Couverture Maladie Universelle (CMU) souffre d'arriérés de paiement chroniques de l'État envers les structures sanitaires (hôpitaux, centres de santé), ce qui fragilise l'offre de soins et entraîne des ruptures d'approvisionnement en médicaments essentiels. De plus, les mutuelles de santé communautaires souffrent d'un faible taux de pénétration en raison du caractère facultatif de l'adhésion et des difficultés de collecte des cotisations auprès des populations rurales à revenus irréguliers, poussant l'administration à envisager des réformes vers l'obligation d'assurance ou l'intégration de la CMU au sein d'un grand régime d'assurance maladie obligatoire unifié.

Enjeux africains

Au niveau du continent africain, l'Union Africaine promeut l'extension de la protection sociale comme un pilier fondamental de la Déclaration de Ouagadougou et de l'Agenda 2063 pour l'Afrique. Les États africains partagent la nécessité de concevoir des mécanismes de protection adaptés à la structure démographique du continent, caractérisée par une informalité dominante et une paysannerie majoritaire, rendant obsolètes les modèles d'assurance sociale occidentaux calqués sur le plein emploi salarié.

Dans l'espace de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), les enjeux se concentrent sur la transférabilité des droits sociaux pour les travailleurs migrants au sein de l'espace communautaire, afin de garantir qu'un citoyen ouest-africain ayant cotisé dans un État membre puisse liquider ses droits à la retraite dans son pays d'origine. L'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) s'investit dans l'harmonisation des réglementations de la mutualité sociale à travers l'adoption du Règlement n° 07/2009/CM/UEMOA, qui offre un cadre juridique unifié et sécurisé pour le développement des mutuelles de santé dans l'ensemble des États membres, renforçant la gouvernance et le contrôle financier de ces structures communautaires.

Enjeux internationaux

À l'échelle internationale, la protection sociale s'aligne sur le socle de protection sociale promu par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) à travers la **Recommandation n° 202 de 2012**. Ce texte international contraignant invite les États à garantir des niveaux minimums de sécurité sociale comprenant l'accès à des soins de santé essentiels et la sécurité du revenu tout au long du cycle de la

vie, en cohérence avec l'atteinte de l'Objectif de Développement Durable 1 (ODD 1) des Nations Unies visant l'éradication de la pauvreté. [\[1\]](#)

Les institutions multilatérales comme la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International ont opéré un tournant doctrinal en reconnaissant que la mise en œuvre de filets de sécurité sociale performants est une condition indispensable à la réussite et à l'acceptabilité politique des réformes de stabilisation macroéconomique. L'aide publique au développement s'oriente massivement vers le financement de l'assistance technique pour la modernisation des registres sociaux et le déploiement de programmes de transferts monétaires indexés sur les risques climatiques (*Adaptive Social Protection*), démontrant l'imbrication étroite entre action sociale locale et gouvernance financière mondiale.

QUATRIÈME PARTIE : ANALYSE CRITIQUE

Forces et avantages

La force majeure du système sénégalais de protection sociale réside dans son ancrage institutionnel de haut niveau et la possession d'un outil de ciblage de classe mondiale qu'est le Registre National Unique. Le RNU immunise l'action sociale contre les dérives du favoritisme et du clientélisme politique en objectivant la pauvreté à travers des critères scientifiques validés de manière participative par les communautés elles-mêmes. De plus, le déploiement combiné des transferts monétaires du PNBSF et des gratuités de la CMU a prouvé son efficacité empirique pour protéger le capital humain des enfants, réduire les taux de déscolarisation précoce et amortir les chocs économiques immédiats au sein des ménages les plus pauvres du pays.

Faiblesses et limites

La principale limite structurelle du système découle de sa **dépendance financière** vis-à-vis des ressources budgétaires générales de l'État et de l'aide publique internationale. Contrairement aux systèmes occidentaux autofinancés par les cotisations sur les salaires, le modèle d'assistance sénégalais repose sur des subventions étatiques directes, le rendant vulnérable aux moindres tensions budgétaires, aux crises de la dette ou aux chocs inflationnistes mondiaux. Par ailleurs, la persistance du fractionnement institutionnel entre les régimes gérés par l'IPRES, la Caisse de Sécurité Sociale, le FNR et l'Agence de la CMU engendre d'importants coûts administratifs redondants, des circuits bureaucratiques complexes pour les usagers et des ruptures de prise en charge préjudiciables à l'équité républicaine.

Débats contemporains

Un débat doctrinal et économique intense agite les décideurs publics sénégalais quant à la viabilité du modèle d'**assistance universelle face au ciblage catégoriel**. Les partisans de l'universalisme (notamment pour la couverture maladie) affirment que le ciblage des seuls pauvres génère des coûts d'identification exorbitants, crée des effets de seuil injustes et stigmatise les bénéficiaires, préconisant une assurance maladie obligatoire universelle financée par une fiscalité sur la consommation de masse. À l'inverse, les économistes orthodoxes rappellent que la rareté des ressources budgétaires impose un ciblage strict des plus indigents pour maximiser l'impact des fonds publics. Un autre débat éthique et sociologique concerne le risque d'instauration d'un réflexe d'assistance et de passivité chez les allocataires des bourses familiales, poussant l'administration à concevoir des programmes de « graduation » pour l'autonomisation économique par le travail des bénéficiaires.

Perspectives d'avenir

L'avenir de la protection sociale au Sénégal dépendra de la réussite de la transition vers un **Régime Unifié d'Assurance Maladie Obligatoire et la formalisation progressive de l'économie**. Les réformes administratives devront fusionner les caisses de prévoyance existantes au sein d'une grande institution publique de sécurité sociale rationalisée, capable de proposer des produits de retraite et d'assurance maladie simplifiés, adaptés aux capacités de contribution irrégulières des travailleurs indépendants et du monde rural (le mécanisme du secteur informel). L'exploitation des technologies numériques de paiement mobile et de la biométrie permettra de réduire à zéro les coûts de transaction, de décentraliser l'accès aux prestations au cœur des collectivités territoriales et d'asseoir le financement de la solidarité nationale sur l'exploitation souveraine des ressources pétrolières et gazières du pays, concrétisant ainsi la promesse constitutionnelle d'une justice sociale universelle.

RÉFÉRENCES ACADÉMIQUES

Auteurs majeurs et ouvrages essentiels

- **Robert Castel** : *Les métamorphoses de la question sociale : Une chronique du salariat* (1995). L'ouvrage de référence qui théorise le passage de la solidarité organique à la sécurité sociale formelle et les risques de désaffiliation sociale.
- **Gøsta Esping-Andersen** : *Les trois mondes de l'économie politique de l'État-providence* (1990). L'œuvre majeure qui modélise les concepts de démarchandisation et de typologie des systèmes de protection sociale.
- **Amartya Sen** : *Repenser l'inégalité* (1992). Le texte fondamental qui expose la théorie des capabilités, boussole des politiques modernes d'assistance active et d'autonomisation des individus vulnérables.
- **Robert Castel et Serge Paugam** : *Les précarités sur le marché du travail* (2000). Une analyse sociologique indispensable pour comprendre la disqualification sociale liée à la dépendance vis-à-vis des secours publics.

Théories importantes et concepts à maîtriser

- **Le modèle bismarckien** : Système de protection sociale fondé sur le travail, financé par des cotisations assises sur les salaires et destiné à prémunir les actifs cotisants contre la perte de revenus professionnels. [\[1, 2\]](#)
- **Le modèle beveridgien** : Système de protection sociale fondé sur la citoyenneté, universel et uniforme, financé par l'impôt général et géré par l'État pour garantir un filet de sécurité minimal à tous les membres de la société.
- **Le ciblage par test des besoins (Proxy Means Testing)** : Méthode statistique utilisée pour identifier les bénéficiaires des programmes sociaux en estimant le revenu d'un ménage à partir de caractéristiques observables (type d'habitat, possession de biens, niveau d'éducation), garantissant l'objectivité du processus. [\[1\]](#)
- **La graduation sociale** : Stratégie d'accompagnement psychosocial et économique visant à doter les bénéficiaires de transferts monétaires de compétences entrepreneuriales et d'accès au microcrédit pour leur permettre de sortir définitivement de la pauvreté et de l'assistance.

RÉFÉRENCES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES

Constitution du Sénégal et lois pertinentes

- **Constitution de la République du Sénégal** : Ses dispositions garantissant l'égal accès des citoyens aux services de santé, à l'éducation, et affirmant le rôle régulateur de l'État dans la redistribution de la richesse nationale et la protection de la famille.
- **Loi n° 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la Sécurité Sociale au Sénégal** : Le texte législatif de référence qui fixe l'organisation, les compétences et les prestations de la Caisse de Sécurité Sociale en matière d'accidents du travail et d'allocations familiales.
- **Loi d'orientation sociale n° 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes en situation de handicap** : Cadre légal majeur instituant la Carte d'Égalité des Chances et les obligations de l'État en matière d'accessibilité et de gratuité thérapeutique pour ce public.

Conventions internationales et institutions

- **Recommandation n° 202 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT, 2012) sur les socles de protection sociale** : Norme internationale contraignante invitant les États membres à mettre en place des garanties de sécurité sociale de base pour l'ensemble de la population.
- **Règlement n° 07/2009/CM/UEMOA portant Code de la mutualité sociale au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine** : Texte communautaire qui régit l'organisation, le contrôle et le fonctionnement financier des mutuelles de santé dans l'espace sous-régional.
- **Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSSN)** : Institution rattachée à la Présidence de la République du Sénégal, chargée de la conception, de la coordination stratégique et du pilotage opérationnel des filets de sécurité sociale de l'État. [[1](#), [2](#)]

APPLICATIONS ET EXEMPLES

Sénégal

Au Sénégal, l'opérationnalisation de la **Carte d'Égalité des Chances (CEC)**, instituée par la Loi d'orientation sociale de 2010, offre un exemple concret d'application d'un instrument médico-social et administratif destiné aux personnes en situation de handicap. Délivrée après une évaluation rigoureuse de la déficience par une commission médicale technique départementale, cette carte est interconnectée avec le Registre National Unique. Elle ouvre un droit automatique à la gratuité totale des soins au sein du réseau des mutuelles de santé de la SEN-CMU, à des bourses de sécurité familiale spécifiques, à des quotas de gratuité dans les transports publics urbains et à des facilités d'accès aux financements de projets d'insertion économique, illustrant une mesure de discrimination positive réussie.

Afrique

Au Rwanda, le système des **Mutuelles de Santé Communautaires (Mutuelles de Santé)** représente l'une des applications les plus performantes d'une politique de protection sociale sanitaire en Afrique subsaharienne. Face à l'effondrement du système de santé au lendemain du génocide de 1994, l'administration rwandaise a rendu l'adhésion aux mutuelles obligatoire pour l'ensemble de la population, en indexant les cotisations annuelles sur le niveau de richesse des ménages évalué par le système de classification communautaire *Ubudehe*. L'État prend en charge 100 % de la cotisation des familles classées indigentes, permettant au pays d'atteindre un taux de couverture universelle de la santé supérieur à 90 %, réduisant drastiquement la mortalité maternelle et infantile.

Europe

En France, la gestion du **Régime Général de la Sécurité Sociale**, créé en 1945 sous l'impulsion du Conseil National de la Résistance et porté par des figures comme Pierre Laroque, illustre l'application historique du modèle de solidarité nationale globale fondé sur la démarchandisation. Ce système repose sur le principe de la répartition et du salaire socialisé : les actifs cotisent sur leur salaire brut pour financer immédiatement les pensions des retraités, les prestations familiales et le remboursement des soins de santé via l'Assurance Maladie, concrétisant la célèbre formule déontologique : « Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins », un modèle de cohésion sociale qui influence les réformes de prévoyance du secteur formel sénégalais.

Amérique

Au Brésil, le programme de transferts monétaires conditionnels **Bolsa Família**, lancé au début des années 2000 et unifié par l'administration fédérale, est un exemple mondial d'ingénierie sociale contracyclique de lutte contre la pauvreté. Ce programme allouait une aide financière mensuelle directe aux mères de familles vivant sous le seuil de pauvreté. Pour maintenir le bénéfice de la bourse, l'administration imposait des critères de conditionnalité stricts : obligation d'assurer une assiduité scolaire supérieure à 85 % pour les enfants et respect du calendrier de suivi médical et de vaccination des nourrissons, démontrant comment un transfert financier à court terme construit le capital humain à long terme d'une nation.

Asie

En Chine, pour étendre la protection sociale au-delà des élites salariées des mégapoles industrielles de l'Est, l'administration a lancé le **Nouveau Régime Médical Coopératif Rural (NRMCR)** au cours de la décennie 2000. Ce dispositif est un mécanisme d'assurance maladie volontaire fortement subventionné par le gouvernement central et les autorités provinciales, exigeant une contribution financière modique de la part des paysans. L'administration utilise le numérique et la décentralisation pour rembourser instantanément les frais d'hospitalisation lourds via des terminaux électroniques villageois, permettant de protéger des centaines de millions d'agriculteurs contre le risque de faillite financière familiale provoqué par la maladie.